

Diretoria de Assistência à Saúde
Diretoria Técnica
Serviço de Neurologia do Hospital Municipal São José

Nota Orientativa Conjunta nº 02/2024 - SES.DAS / DTE

Assunto: Continuidade do cuidado ao usuário acometido por Acidente Vascular Cerebral (AVC) nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) após alta hospitalar

Considerando a Portaria Nº 173/2021/SMS, de 24 de maio de 2021, que Institui a "Linha de Cuidado do Acidente Vascular Cerebral (AVC)" no Município de Joinville (disponível no processo do Sistema Eletrônico de Informações - SEI Nº 20.0.167920-8);

Considerando a importância da garantia de acesso à prevenção secundária com controle rigoroso dos fatores de risco, identificação das necessidades e acesso à reabilitação para promoção da qualidade de vida das pessoas que convivem com a doença, continuidade do cuidado na reabilitação e orientação à rede de apoio do usuário pós-AVC após a alta hospitalar;

A Diretoria de Assistência à Saúde, a Diretoria Técnica e o Serviço de Neurologia do Hospital Municipal São José, orientam os profissionais médicos das UBSFs acerca da prevenção secundária e continuidade do cuidado ao usuário acometido por AVC após a alta hospitalar.

CONTINUIDADE DO CUIDADO AO USUÁRIO PÓS-AVC NAS UBSFs

Como regra geral, a continuidade do cuidado aos usuários pós AVC se dá na adesão às orientações, recomendações e indicações clínicas e terapêuticas expressas no documento de alta hospitalar registrado na contrarreferência (disponível no Sistema Integrado de Gestão - SIG-SaudeTech) à Unidade de Saúde de referência.

Notas:

- É atribuição da equipe da Atenção Primária à Saúde (APS) conferir e acompanhar se a prescrição médica e orientações de alta estão sendo seguidas pelo usuário e cuidadores, para adequada reabilitação;
- Para acesso aos dados da contrarreferência sugere-se seguir o Procedimento Operacional Padrão – POP SES.APS nº 19 – “Solicitar o cuidado compartilhado via Notificação de Contrarreferência (NCR) no SIG-SaudeTech”, disponível no processo SEI Nº 22.0.398763-9.

Elencamos a seguir os tópicos indispensáveis para acompanhamento pelas UBSFs:

1. DA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS PÓS AVC

1.1. Antiagregantes Plaquetários

- a) Usuários que receberam alta hospitalar pós AVC com prescrição de **Clopidogrel**, seja por resistência a Ácido Acetilsalicílico (AAS) ou outro motivo:

→ **Conduta:** prescrição médica de Clopidogrel 75mg/dia, PERMANENTEMENTE;

- b) Usuários que receberam alta hospitalar pós AVC com prescrição de **Dupla Antiagregação Plaquetária (AAS 100 mg + Clopidogrel 75mg)**:

→ **Conduta:**

b.1) AVC de etiologia aterotrombótica: manter o uso de AAS 100 mg + Clopidogrel 75mg por um período de 21 a 90 dias, conforme orientações de alta;

b.2) AVC com realização de angioplastia e/ou colocação de stent: manter AAS 100 mg + Clopidogrel 75mg por 6 meses a 1 ano, conforme orientações de alta;

IMPORTANTE: Após o tempo previsto da dupla antiagregação, os usuários geralmente manterão AAS 100mg/dia PERMANENTEMENTE.

- c) Usuários que apresentarem algum efeito colateral (sintomas gástricos por exemplo) ou outra **contra-indicação ao AAS**:

→ **Conduta:** substituir o AAS, prescrevendo Clopidogrel 75mg/dia;

- d) Usuários que receberam alta hospitalar pós AVC com prescrição de **Tripla Antiagregação Plaquetária (AAS 100 mg + Clopidogrel 75mg + Cilostazol 100mg 12/12hs)**:

→ **Conduta:** identificar na contrarreferência o período de tratamento, que pode variar de acordo com a complexidade de cada caso. Esses casos devem manter acompanhamento em ambulatório de neurologia ou neurorradiologia (encaminhados no momento da alta hospitalar).

IMPORTANTE: Evitar uso indiscriminado de inibidores de bomba de prótons por potencial interferência na antiagregação plaquetária. Quando utilizar Clopidogrel, deve-se preferir o uso de IBPs com inibição do CYP2C19 mais fraca (como o pantoprazol). Para mais informações acessar o link: [Protocolo de Prescrição e Dispensação de Antiagregantes Plaquetários](#).

1.2. Anticoagulantes

Usuários que receberam alta hospitalar com prescrição de anticoagulação pós AVC de etiologia cardioembólica por Fibrilação Atrial (FA):

→ **Conduta:** Priorizar a classe dos anticoagulantes orais diretos (**DOACs, do inglês *direct oral anticoagulants***), notadamente Eliquis (**Apixabana**), sempre que o usuário tenha recebido esta prescrição na alta hospitalar, devido melhor perfil para redução de risco de sangramento.

a) **Eliquis (Apixabana) 5mg 12/12h Via Oral (VO):** se pelo menos 2 de 3 critérios abaixo descritos presentes, a dose de Eliquis 5mg deve ser reduzida para 2,5mg 12/12h VO

- Creatinina: > 1,5 mg/dL;
- Idade: > 80 anos;
- Peso: < 60kg;

b) **Xarelto (Rivaroxabana) 20mg VO:** ao dia (devendo a tomada do medicamento ser realizada junto com a refeição)

- Clearance de creatinina 30-50 mL/min = **Conduta:** 15 mg ao dia VO;
- Clearance de creatinina 15-30 mL/min = **Conduta:** Avaliar risco x benefício = 15 mg ao dia VO;
- Clearance de creatinina <15 mL/min = **Conduta:** Uso não recomendado;

IMPORTANTE: Sempre atentar à disfunção renal e sangramentos ocultos.

Notas:

- Atentar para a necessidade de acompanhamento laboratorial, que deve ter periodicidade mínima semestral, para os seguintes exames:
 - Creatinina (usar CKD-EPI para cálculo do clearance de creatinina);
 - Uréia;
 - Hemograma de rotina;
- Avaliação clínica ativa em busca de sangramento gastrointestinal.

c) **Varfarina:** indicada para AVC cardioembólico por FA e todas as demais etiologias cardioembólicas, tendo como alvos de RNI (Relação Normalizada Internacional):

- RNI entre 2 a 3: FA, Acinesia do Ventrículo Esquerdo, Trombose Venosa Cerebral;
- RNI entre 2,5 a 3,5: Prótese valvar metálica;

→ **Condutas:**

- Atentar para orientações nutricionais devido à interação com alimentos ricos em vitamina K (a ingesta de verdes deve ter diariamente a mesma quantidade/volume);
- Atentar para interações medicamentosas;
- Utilização de caderneta de anticoagulação (entregue na alta);
- Ao identificar necessidade de Anticoagulação Oral Contínua, o médico assistente da APS poderá seguir as orientações e encaminhar o usuário à Unidade de Saúde Digital - Ligue Web Saúde (LWS), conforme descrito no “Protocolo de Anticoagulação” e “Fluxograma de Acesso à Anticoagulação Oral” (disponíveis no processo SEI N° 22.0.197831-4).

Observação: Na Trombose Venosa Cerebral manter no mínimo 6 meses de anticoagulação com Varfarina e alvo RNI: 2 a 3.

2. DOS CUIDADOS GERAIS PARA USUÁRIOS PÓS AVC

2.1 Controle Pressórico

O objetivo é buscar manter a Pressão Arterial (PA) no menor valor possível onde o usuário se mantenha assintomático, conforme orientações de alta, pois em alguns casos deve-se ser mais permissivo, como por exemplo, quando existe risco de hipofluxo cerebral.

→ **Meta para a PA:** < 130/85 mmHg.

2.2. Controle Glicêmico

Consiste em avaliar o usuário através do exame Hemoglobina Glicada (HbA1c), procurando manter os índices dentro dos limiares expressos abaixo:

→ **Metas para o HbA1c:**

- Usuários portadores de Diabetes Mellitus (DM): < 7,0 mg/dL;
- Adulto Hígido: < 5,5 mg/dL;
- Idoso Hígido: < 7,5 mg/dL;
- Idoso Frágil: < 8,0 mg/dL;

2.2. Controle da Dislipidemia

Avaliar e nortear a meta para os exames laboratoriais descritos abaixo:

- **Meta para HDL:** > 45 mg/dL;
- **Meta para LDL:** < 70 mg/dL;
- **Meta para TG:** < 150 mg/dL;

Observação: havendo necessidade de prescrição de Estatinas, sugere-se idealmente a prescrição de Atorvastatina 40mg/dia (necessita preenchimento do Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamento(s) - LME). Para proceder com o LME acessar o link: [Componente Especializado da Assistência Farmacêutica](#).

2.3. Controle do Tabagismo

Ao usuário tabagista que iniciou abstinência durante o período de internação, na contrarreferência deve-se recomendar o acolhimento e avaliação clínica pelo médico capacitado em "Abordagem e Tratamento do Tabagismo no SUS" da Unidade de Saúde de referência.

Caberá ao médico da UBSF definir a abordagem (mínima ou intensiva, individual ou em grupo) para a continuidade do tratamento tabagista levando em consideração o perfil do usuário, condições clínicas e oferta de atendimento da Unidade.

Todo usuário tabagista que recebe indicação de acompanhamento para manutenção da abstinência na alta hospitalar deve ser avaliado pelo Médico da UBSF em até, no máximo, 30 dias após a alta.

2.4. Acompanhamento e Avaliação de Funções Cognitivas

Aplicar regularmente a “**Escala Montreal Cognitive Assessment**” - “**MoCA**” (disponível no processo SEI N° 20.0.167920-8, ou através do site <https://avc.org.br/membros/escalas-de-avc/>): usada para triagem de demências em geral.

- **Encaminhar** o usuário à Neurologia (via sistema de regulação - SISREG) sempre que houver piora significativa no score: maior ou igual a 4 pontos ou pontuação menor ou igual a 26 pontos.

2.5. Acompanhamento Multidisciplinar

2.5.1. Indicações de Acompanhamento com Fisioterapia

Sugere-se a utilização da “**Escala Modificada de Barthel**” (disponível no processo SEI N° 20.0.167920-8, ou através do site <https://avc.org.br/membros/escalas-de-avc/>), que pode ser encontrada no sistema SIG-SaudeTech em modelos de evolução: “Índice de Barthel”: **indicada reabilitação** sempre que a pontuação da escala for abaixo de 70.

- **Encaminhar** o usuário, via sistema SIG-SaudeTech, à uma clínica de Fisioterapia conveniada, que presta atendimento em neuroreabilitação;
- Demais condutas:
 - Detecção precoce de espasticidade (rigidez muscular) - encaminhar à Neurologia Adulto Geral via sistema SIG-SaudeTech, para avaliação de necessidade de Toxina Botulínica;
 - Atenção para prevenção de dor crônica;
 - Foco na independência para marcha e transferências.

2.5.2. Indicações de Acompanhamento com Fonoaudiologia

- Disfagia;
 - Distúrbios de Comunicação/Linguagem.
- **Encaminhar** o usuário à Fonoaudiologia via sistema SISREG.

2.5.3. Atividade Física

Realizar avaliação funcional utilizando a “**Escala de Rankin Modificada**” (disponível no processo SEI N° 20.0.167920-8, ou através do site <https://avc.org.br/membros/escalas-de-avc/>), o mesmo documento encontra-se no sistema SIG-SaudeTech em modelos de evolução.

- **Estimular** a atividade física em qualquer grau de incapacidade, inclusive cadeirantes, para “**mRankin**”: < 4;
- **Encaminhar** o usuário para grupos (de acompanhamento com Educador Físico) existentes nos Distritos Sanitários (Norte/Sul/Centro) de referência da Rede de Atenção à Saúde ou outros grupos disponíveis no território.

Observação: atentar-se para as orientações disponíveis na contrarreferência em relatório de alta.

2.5.4. Indicações de Acompanhamento com a Terapia Ocupacional

Para casos em que no relatório de alta constam as seguintes descrições:

- Alteração da motilidade ocular ou déficit visual (hemianopsia / negligência);
- Ataxia;
- Paresia / Plegia: foco em membro superior;
- Extinção / Inatenção / Negligência;
- Déficit Cognitivo;

→ **Encaminhar** o usuário para o profissional de Terapia Ocupacional de referência do território e/ou Distrito Sanitário (Norte / Sul / Centro) de referência.

2.5.5. Indicações de Acompanhamento Nutricional

Encaminhar o usuário para o profissional Nutricionista de referência do território e/ou Distrito Sanitário (Norte / Sul / Centro), nas seguintes condições:

- Nas possibilidades de interação medicamentosa, como no caso da varfarina;
- Desnutrição / Sobrepeso / Obesidade;
- Controle da ingestão de sódio e açúcares.

2.5.6. Indicação de Acompanhamento Psicológico

Encaminhar o usuário para o profissional Psicólogo de referência do território e/ou Distrito Sanitário (Norte / Sul / Centro), nas seguintes condições:

- Depressão pós AVC;
- Ansiedade pós AVC;
- Atenção ao cuidador.

Nota: Quando o usuário comportar critérios para encaminhamento à **duas ou mais especialidades** descritas no **item 2.7** acima, recomenda-se o encaminhamento para o Serviço Especializado de Reabilitação (SER), através de solicitação via SIG-SaudeTech em “Requisição de Procedimentos”.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3.1. Unidade de Saúde Digital (USD)

Além do Ambulatório Virtual de Anticoagulação, a Unidade de Saúde Digital participa do cuidado pós AVC, através de um instrumento compartilhado com o Hospital Municipal São José (Joinvasc).

A USD realiza teleconsulta médica em até 7 dias após a desospitalização, telenfermagem em até 30 dias e em 60 dias. Os atendimentos objetivam, especialmente, garantir a continuidade do cuidado, a prevenção secundária e orientações para inferência nos fatores de risco, evitando a recorrência do evento. Tal ação não substitui o cuidado na APS, conforme descrito na Linha de Cuidado à pessoa com AVC, disponível no processo SEI N° 20.0.167920-8.

3.2. Materiais educativos

Para auxiliar na detecção precoce de fatores de risco, nas orientações da prevenção secundária e, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas portadoras de sequelas do AVC, seus familiares e cuidadores, a Associação Brasil AVC (ABAVC) desenvolve documentos que podem ser utilizados pelos profissionais de saúde.

Para mais informações, acessar o link: ["Materiais / Sobre o AVC"](#).

3.3. Manual da Equipe Multiprofissional (eMulti)

Casos de indicação e acompanhamento com eMulti, verificar o “Manual da Equipe Multiprofissional na Atenção Primária à Saúde” e seus anexos, disponíveis no processo SEI N° 23.0.029059-0.

3.4. Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS)

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) estão disponíveis na Rede de Saúde do Município de Joinville. Contemplam recursos terapêuticos que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. A disponibilidade e oferta das PICS varia de acordo com a formação de cada profissional e, recomenda-se que se verifique a oferta no território e/ou Distrito Sanitário antes de encaminhar o usuário.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Associação Brasil AVC. **Sobre o AVC - Materiais Informativos**. Disponível em: <<https://abavc.org.br/index.php/materiais/>>. Acesso em: 01 de agosto de 2024;

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Portaria N° 761/SAS/MS, de 21 de junho de 2016**. Valida as orientações técnicas do tratamento do tabagismo constantes no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Dependência à Nicotina. Brasília - DF: 2016;

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Estado da Saúde. Assistência Farmacêutica. **Laudos de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamento(s) - LME**. Disponível em: <<https://www.saude.sc.gov.br/index.php/informacoes-gerais-documentos/assistencia-farmaceutica/componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-ceaf/documentos/laudo-para-solicitacao-a-valiacao-e-autorizacao-de-medicamentos-lme/17909-lme-preenchimento-eletronico/file>>. Brasília - DF: 2024;

SANTA CATARINA. Prefeitura de Joinville. Secretaria da Saúde. Diretoria de Assistência à Saúde. Sistema Eletrônico de Informação - SEI. **Manual da Equipe Multiprofissional na Atenção Primária à Saúde**. Joinville - SC: 2023;

SANTA CATARINA. Prefeitura de Joinville. Secretaria da Saúde. Diretoria de Assistência à Saúde. Sistema Eletrônico de Informação - SEI. **Procedimento Operacional Padrão - POP SES.APS nº 19 - Solicitar o cuidado compartilhado via Notificação de Contrarreferência (NCR) no SIG-SaúdeTech**. Joinville - SC: 2022;

SANTA CATARINA. Prefeitura de Joinville. Secretaria da Saúde. Diretoria de Assistência à Saúde. Sistema Eletrônico de Informação - SEI. **Protocolo de Anticoagulação Oral**. Joinville - SC: 2022;

SANTA CATARINA. Prefeitura de Joinville. Secretaria da Saúde. Diretoria de Assistência à Saúde. Sistema Eletrônico de Informação - SEI. **Protocolo de Prescrição e Dispensação de Antiagregantes Plaquetários - Diretriz para Antiagregação Plaquetária Ambulatorial no âmbito do Município de Joinville**. Joinville - SC: 2020;

SANTA CATARINA. Prefeitura de Joinville. Secretaria da Saúde. Gabinete do Secretário. **Portaria N° 173/2019/SMS, de 23 de setembro de 2019**. Dispõe sobre as normas gerais das PICs - Práticas Integrativas e Complementares na Rede Municipal de Saúde de Joinville/SC. Joinville - SC: 2019;

SANTA CATARINA. Prefeitura de Joinville. Secretaria da Saúde. Gabinete do Secretário. **Portaria N° 173/2021/SMS, de 24 de maio de 2021**. Institui a Linha de Cuidado do Acidente Vascular Cerebral (AVC) no Município de Joinville. Joinville - SC: 2021.